EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 95302
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-21 12:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO ENRIQUE ESNIDA SEPULVEDA			RUN	: 4.000.616-8
F.Nac	: 05-01-2022	Edad	: 2 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-10-12	Fecha Egreso	: 2024-10-21 12:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE 86 AÑOS ANTECEDENTE DE RECIENTE HOSPITALIZACION POR SEPSIS DE FOCO URINARIA E COLI BLEE EN SEPTIEMBRE, DEPENDIENTE MODERADO A SEVERO, REFIERE QUE CUMPLE SU TRATAMIENTO ANTIBIOTICO, ACTUALMENTE CONSULTA POR PRESENTAR DOLOR ABDOMINAL, NAUSEAOSO, ORINAS OSCURAS Y 6 DIAS SIN DEPOSICIONES, ESCALOFRIOS, CONSULTA EN SAPU DEL CESFAM, MEDICO DE APS REALIZA EXAMENES DE LAB Y DERIVA A HSC POR EXAMENES DE LAB. ALTERADOS. Creatinina : 2,00 * mg/dl, Calcio : 7,8 * mg/dL, Proteina C Reactiva : 285,8 * mg/L, Nitrógeno Ureico : 32 * mg/dL, POR ANTECEDENTE DE ITU BLEE, MEDICO DEL SERVICIO DE URGENCIA, DECIDE HOSPITALIZAR, SE REALIZA UROCULTIVO POR ANTECEDENTE DE E COLI BLEE, HEMOCULTIVO Y A LAS 11 HORAS SALE + PARA GRAM NEGATIVO.
PACIENTE INGRESA AL SERVICIO DE MEDICINA, AFEBRIL, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SE MANTIENE NAUSEOSO Y CON DOLOR ABDOMINAL EN REGION MESOGASTRIO Y AMBOS FLANCOS. POR ANTECEDENTE DE HOSPITALIZACION POR ECOLIG BLEE Y HEMOCULTIVO EN PREINFORME + PARA GRAM NEGATIVO, SE DECIDE MANTENER EN AISLAMIENTO DE CONTACTO E INICIAR TRATAMIENTO CON ATB DE AMPLIO ESPECTRO.

DESDE SU INGRESO SE INICIA TERAPIA ATB CON MEROPENEM, URC CON DESARROLLO DE E COLI BLEE (+), EN VISTA DE DESARROLLO DE hc POSITIVOS, SE INICIA TERAPIA BIASOCIADA CON VANCOMICINA, CON MEJORIA DE PARAMETROS INFLAMATORIOS EN CONTROLES POTERIORES, DESDE ESFERA RENAL SE INICIA VOLEMIZACION, SUMADO A TERAPIA DE SOPORTE, CON MEJORIA PORGRESIVA DE PARAMETROS INFLAMATORIOS

paciente HDN estable, afebril,. sin dolor, con buena tolerancia a alimentacion VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos, diuresis 800 cc, deposiciones (-)

Ex de lab -> crea 1,3; lactato 1,9; PCR 49,6; Na/K/Cl 148/4,7/110; Gb 12,3; Hb/HCto 12/36,8; plaq 270000; segment 55%

Ex fisico -> Vigil; CLOTE, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoenal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

ACTUALMENTE CURSANDO SU DIA N° 9 DE TERAPIA ATB MEROPENEM/VANCOMICINA, EN CONDICIONES DE CONTINUAR HOSPITALIZACION VIA HODOM

PLAN DE MANEJO:

HDN: estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con parametros inflamatorios a la baja, se rotara carbapenemico a ertapemen y se completaran 14 dias de terapia ATB en total a traves de HODOm, se solicitaran examenes de lab dentro de 48 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo semisentado 30°
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Alslamiento de contacto
4. Ertapemen 1 gr al dia EV por 5 dias
5. Vancomicina 1 gr al dia EV por 5 dias
6. paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO por 5 dias
7. Bisoprolol 2,5 mg al dia VO por 5 dias
8. Diltiazem 60 mg c/8hrs VO por 5 dias
9. Carbamazepina 200 mg 2-0-1 VO por 5 dias
10. Alprazolam 0,5 mg al dia VO por 5 dias
11. Lactulosa 20 cc c/8hrs VO por 5 dias
12. Quetiapina 100 mg al dia VO por 5 dias
13. Pregabalina 75 mg c/12 hrs VO por 5 dias
14. KNT motora una vez al dia
15. Examenes de control 23/10

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO